Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/9	
Título do Documento	**PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA**	Emissão: 31/05/2026 Versão: 2	Próxima revisão: 31/05/2027

1. CONCEITO: A infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) é caracterizada pela presença de microrganismos na corrente sanguínea, cuja origem não está associada a nenhum outro foco infeccioso identificado. Nesse contexto, o foco primário é a própria corrente sanguínea.

1.1 Responsáveis pela execução

Profissionais de saúde assistencialistas.

1.2 Finalidade

- Padronizar as ações que reduzam os riscos e previnam infecção primária de corrente sanguínea relacionada a cateteres vasculares centrais e periféricos.

1.3 Indicações

Pacientes em uso de cateteres vasculares centrais e periféricos durante internação nosocomial.

2. MATERIAIS

- EPIs
- Preparação alcóolica ou sabonete líquido
- Check list de Inserção de CVC
- Bundle de manutenção CVC

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS

Seleção do cateter

Selecionar o cateter intravenoso periférico de acordo com:

- A indicação clínica;
- Tipo de solução intravenosa;
- Duração da terapia ou tempo de permanência no local;
- Condições das veias;
- Necessidades de infusão, considerando: − material da cânula do cateter, design e calibres
- Escolher cateter de menor calibre em relação à veia para minimizar risco de flebite mecânica e flebite química.
- Comprimento: selecionar o CIVP curto de menor calibre de acordo com a terapia prescrita e a necessidade do paciente;

Seleção do vaso periférico

- Considerar a preferência do paciente na escolha do membro para inserção do CIVP;
- Utilizar um local de inserção no membro não dominante;
- Evitar locais de inserção localizados em locais de flexão, membros comprometidos por lesões, infecções nas extremidades, veias com sinais e sintomas de flebite, áreas com infiltração ou extravasamento prévios e plegias;
- Não puncionar veias em membros de futuros procedimentos, como fístulas arteriovenosas, cateteres centrais inseridos por veias periféricas, dentre outros; e das extremidades inferiores, a menos que seja necessário para uma inserção de emergência.

Inserção do cateter

- Usar garrote descartável ou passível de desinfecção entre pacientes;
- Limitar no máximo a duas tentativas de punção venosa periférica por profissional.
- Utilizar um novo CIVP a cada tentativa de punção no mesmo paciente.

Manutenção do cateter periférico

- Proteger o local de inserção com material impermeável durante o banho;
- Verificar as condições da cobertura e a necessidade de substituição do cateter por meio de inspeção visual e palpação externa da cobertura intacta;
- Atentar para queixas do paciente como sinais de desconforto, dor e parestesia;
- Avaliar o local de inserção do dispositivo periférico e áreas ao redor quanto à presença de rubor, edema ou secreção, a cada quatro horas ou conforme criticidade do paciente.

3.2 CATETERES CENTRAIS

Escolha do local de inserção do cateter central

- Dar preferência à veia subclávia.

Inserção do cateter central

- Aplicar o checklist de inserção de cateter central;
- Utilizar barreira máxima estéril no momento da inserção dos cateteres centrais:
  - ✓ todos os profissionais envolvidos na inserção devem utilizar gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e óculos de proteção;
  - ✓ utilizar campo estéril ampliado, de forma a cobrir o corpo todo do paciente (cabeça aos pés);
- Preferir inserção guiada por ultrassom;
- Utilizar kits de inserção de cateter;
- Os profissionais de saúde que estiverem observando a inserção do DAVC podem interromper o procedimento se observarem quebras na técnica asséptica.

Manutenção do cateter central

- Desinfetar os hubs de cateter, conectores livres de agulha ou locais para administração de medicamentos antes de manusear o cateter, por pelo menos 5 segundos;
- Avaliar, no mínimo uma vez ao dia, o local de inserção dos cateteres centrais, por inspeção visual e palpação sobre a cobertura intacta;
- Aplicar checklist de manutenção de cateter central.

Troca do cateter central

- Utilizar as mesmas medidas de barreira da inserção de cateter central para a troca do cateter por fio guia.
- Procedimento indicado se não houver suspeita de infecção intraluminal do cateter;
- Cateteres inseridos em emergência e que não tenham seguido a técnica adequada de paramentação e antissepsia da pele devem ser trocados para outro local, assim que possível, em até 48 horas.

3.3 MEDIDAS GERAIS

Higiene das mãos (HM)

- Higienizar as mãos com agua e sabonete líquido ou preparação alcoólica.
- Utilizar água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, e quando os cuidados forem realizados em pacientes em precaução por colonização/infecção por Clostridium dificillie;
- Realizar a HM nos 5 momentos, incluindo:
  - ✓ Imediatamente antes de qualquer manipulação do cateter e sistema de administração de medicamentos, como: inserção do cateter, remoção do cateter, troca de cobertura, coleta de sangue, quando acessar o sistema de infusão e equipos, e no preparo de medicamentos para administração no cateter;
  - ✓ Após tocar o local de inserção do cateter, bem como antes e após a inserção, remoção, manipulação ou troca de cobertura;
  - ✓ Imediatamente após qualquer contato que possa envolver exposição a fluidos corporais, tais como: inserção ou remoção do cateter e coleta sangue;
- Higienizar as mãos antes de calçar as luvas e após retirá-las

Preparo da pele

- Realizar a remoção dos pelos, quando necessária, com tricotomizador elétrico ou tesouras (não utilizar lâmina de barbear);
- Realizar limpeza em caso de sujidade visível no local da futura punção, seja periférica ou profunda, com água e sabonete líquido;
- Realizar a antissepsia da pele com clorexidina alcóolica a 5% ;

Utilização de luvas

- O uso de luvas está indicado apenas quando:
- ✓ Há risco de contato com sangue ou fluidos corporais durante a manipulação do cateter;
- ✓ Em caso de instalação de medicamentos quimioterápicos e antineoplásicos;
- ✓ Em situações em que seja necessária a palpação do local de inserção após a antissepsia (calçar luvas estéreis antes do procedimento).

Estabilização do dispositivo

- Estabilizar o cateter de modo a preservar sua integridade, prevenir seu deslocamento e perda;
- A estabilização não deve interferir na avaliação do local de inserção ou dificultar a infusão da terapia.
- Usar técnica asséptica;
- Não utilizar fitas adesivas não estéreis (esparadrapo ou micropore) para estabilização ou cobertura de cateteres;
- Considerar o uso de dispositivos de estabilização sem sutura para redução do risco de IPCS;
- Estabilizar a cânula do cateter antes de realizar o curativo/ cobertura.

Cobertura dos cateteres

- Utilizar cobertura estéril;
- Selecionar o tipo de cobertura de acordo com: O tipo de cateter; Risco de sangramento ou infecção; Condição da pele; Alergias ou sensibilidades conhecidas; Tamanho e preferência do paciente; Custo; e tempo de uso e facilidade de uso do curativo (mínimo de trocas possíveis);
- Preferir cobertura transparente, utilizar gaze estéril e cobertura estéril nas primeiras 24 horas pós punção e considerar quando presença de sangramento ativo em local de inserção do cateter ou apenas quando a previsão de acesso for menor que 48h;
- Usar cobertura com gaze estéril no local de inserção do cateter sempre que houver drenagem, excetuando-se os casos em que for utilizado agente hemostático para absorção da drenagem sanguinolenta, ou quando o paciente apresentar sudorese profusa (diaforese);
- Trocar cobertura transparente estéril, pelo menos a cada 7 dias ou imediatamente se a integridade da cobertura for comprometida (com presença de sujidade, umidade ou solto) ou se a integridade da pele sob a cobertura estiver comprometida;
- Trocar a gaze estéril e o filme transparente para DAVC no máximo a cada 2 dias ou quando for necessário; ou se a integridade da cobertura estiver comprometida por umidade, soltando ou visivelmente suja);
- Realizar técnica asséptica durante a troca de coberturas (usar luvas estéreis se houver necessidade de tocar o local de inserção);
- Proteger as coberturas, cateteres e conexões com plástico impermeável durante o banho;
- Utilizar cobertura com cuidado em pacientes com pele frágil;
- Observar presença de eritema e dermatite no local da cobertura e atentar para a secagem completa antisséptico para evitar reações na pele.

Prevenção de obstrução dos dispositivos de acessos vasculares

- Realizar a desinfecção das conexões antes de realizar flushing ou locking;
- Realizar flushing e aspiração para verificar retorno de sangue antes de cada infusão, para garantir funcionamento do cateter e prevenir complicações;
- Realizar flushing após cada infusão para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis;
- Utilizar frascos/flaconetes de dose única ou seringas pré preenchidas com solução de cloreto de sódio 0,9% sem conservantes e específicas para flushing de cateteres;
- Não utilizar seringas pré-preenchidas com solução de cloreto de sódio 0,9% para diluição de medicamentos;
- Não usar água estéril para realização do flushing em DAVC;

- Avaliar a permeabilidade do DAVC com seringas de diâmetro de 10 mL ou uma seringa projetada especificamente para gerar pressão de injeção mais baixa (ou seja, corpo de seringa de 10 mL de diâmetro) no lúmen do cateter e identificar qualquer tipo de resistência;
- Utilizar técnica de pressão positiva para minimizar o refluxo de sangue para o lúmen do DAVC;
- ealizar o locking de cada lúmen do DAVC após a conclusão do flush final;
- Realizar o locking dos cateteres intravenosos periféricos (CIVP) curtos e longos e os cateteres de linha média, imediatamente após cada uso;
- Evitar o refluxo de conexão/desconexão usando a sequência apropriada para o flushing, clampeamento da via e desconexão, determinada pelo tipo de conector livre de agulha que está sendo usado (conforme recomendações do fabricante);
- Realizar o locking dos DAVC com cloreto de sódio a 0,9% isentos de conservantes.

Troca ou remoção do cateter intravenoso periférico (CIVP)

- Avaliar diariamente a necessidade de permanência do CIVP;
- Remover caso não esteja em uso no período ≥ 24 horas;
- Remover quando não houver medicamentos endovenosos prescritos;
- Trocar o CIVP que foi inserido em situação de emergência, com riscos de comprometimento de técnica asséptica, o mais breve possível, dentro de 24 a 48 horas, ou assim que a condição clínica do paciente permitir;
- Remover o CIVP com base na avaliação do local (sítio de inserção e integridade da pele) e/ou sinais clínicos e sintomas de complicações sistêmicas: flebite, infiltração, extravasamento, obstrução, deslocamento, infecção ou mau funcionamento.
- Realizar a troca em até 96 horas da inserção.

Troca ou remoção do Dispositivo de acesso vascular central (DAVC)

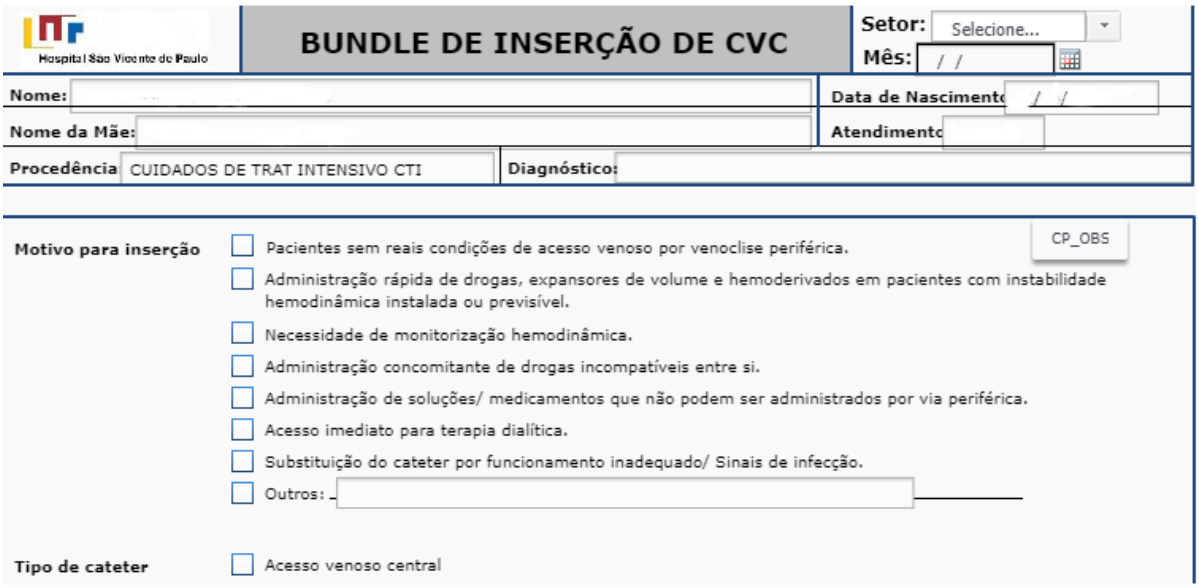
- Avaliar a necessidade de permanência do DAVC diariamente;
- Remover cateteres desnecessários;
- Não realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não os substituir exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência.
- Trocas por fio guia, no caso de cateteres centrais de curta permanência, em geral devem ser limitadas a complicações não infecciosas (ruptura e obstrução).

Orientação de pacientes e acompanhantes

- Orientar pacientes e acompanhantes quanto às medidas de prevenção de IPCS como, evitar tocar na área do cateter, higienizar as mãos, não molhar a região do cateter.

4. ANEXO I

4.1 Bundlle de inserção de cateter central



Hospital São Vicente de Paulo

BUNDLE DE INSERÇÃO DE CVC

Setor: Selecione...

Mês: / /

Nome:

Data de Nascimento / /

Nome da Mãe:

Atendimento

Procedência: CUIDADOS DE TRAT INTENSIVO CTI

Diagnóstico:

Motivo para inserção

CP_OBS

- ☐ Pacientes sem reais condições de acesso venoso por venoclise periférica.
- ☐ Administração rápida de drogas, expansores de volume e hemoderivados em pacientes com instabilidade hemodinâmica instalada ou previsível.
- ☐ Necessidade de monitorização hemodinâmica.
- ☐ Administração concomitante de drogas incompatíveis entre si.
- ☐ Administração de soluções/ medicamentos que não podem ser administrados por via periférica.
- ☐ Acesso imediato para terapia dialítica.
- ☐ Substituição do cateter por funcionamento inadequado/ Sinais de infecção.
- ☐ Outros: _____

Tipo de cateter

- ☐ Acesso venoso central

5. ANEXO II

.1 Bundlle de manutenção de cateter central

Hospital São Vicente de Paulo

BUNDLE DE MANUTENÇÃO DE CVC

Setor: Selecione...

Mês: / /

Nome:

Data de Nascimento

Nome da Mãe:

Atendimento

Leito: CUIDADOS DE TRAT INTENSIVO CTI

Data da inserção do Cateter: / /

Realização do curativo nas primeira 24 horas com gaze estéril ☐ SIM ☐ NÃO

No campo de observação colocar o aspecto da inserção do cateter

Data	Curativo do cateter estéril	Curativo está datado e seguindo o prazo de troca	Realizado higienização das mãos antes de manipular o	Desinfecção das conexões com	Assinatura do Profissional
01					
02					
03					
04					
05					

5. REFERÊNCIAS

1. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/HIMJ_protocolo_ITU_1254773676.pdf
2. https://www.hcor.com.br/area-medica/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/PROTOCOLOS_PRONTO_SOCORRO_INFECCAO_TRATO_URINARIO_v2_web-1.pdf
3. https://sogirgs.org.br/area-do-associado/Infeccao-do-trato-urinario-2021.pdf
4. https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Infeccao-do-Trato-Urinario.pdf
5. https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-geniturin%C3%A1rios/infec%C3%A7%C3%B5es-do-trato-urin%C3%A1rio/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-do-trato-
6. https://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-and-asymptomatic-bacteriuria-in-pregnancy?search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&source=search_result&selectedTitle=3%7E150&usage_type=default&display_rank=2#H10urin%C3%A1rio#Diagn%C3%B3stico_v1052863_pt
7. https://www.uptodate.com/contents/acute-complicated-urinary-tract-infection-including-pyelonephritis-in-adults-and-adolescents?sectionName=Directed%20antimicrobial%20therapy&search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&topicRef=8065&anchor=H945200358&source=see_link#H945200358
8. https://www.hupe.uerj.br/wp-content/uploads/2023/07/Manual-para-Preparo-e-Administra%C3%A7%C3%A3o-de-Medicamentos-Intravenosos_Final_02jul23-1.pdf
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9598998/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33309610/
11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30094687/
12. https://www.ics.org/2023/abstract/426
13. https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340026535PNG_RIAE_Longa.pdf
14. https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/Ficha_tecnica_indicador_11.pdf
15. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): Infecção Primária de Corrente Sanguínea, Brasília-DF, 2025.
16. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): Infecção Primária de Corrente Sanguínea, Brasília-DF, 2026.
17.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
	31/05/2025	Elaboração
	31/05/2025	Aprovação e publicação
	31/05/2026	Atualização

Versão 1 – Elaboração Elaboração Júlia Regina Chaves Pires Leite Ana Carolina Gomes de Farias **Versão 2 –Atualização** Júlia Regina Chaves Pires Leite Ana Carolina Gomes de Farias **Validação/Revisão** Nayanne I. F. Mota Guerra Giuliana Marçal Matheus Soares **Aprovação** Matheus Soares Sônia da Silva Delgado	Data: 31/05/2025 Data: 31/05/2026